Obstrucción intestinal

FISIOPATOLOGIA · Clase 30 · íleo mecánico y paralítico, causas, fisiopatología alta y baja, clínica y radiografía

1 · QUÉ ES LA OBSTRUCCIÓN Y SUS DOS TIPOS

F1 — **Obstrucción intestinal**
interrupción del tránsito de sólidos, líquidos y gases

o se presenta como

se presenta como

F5 — **Íleo mecánico**
hay un obstáculo en la luz; motilidad conservada o exacerbada

F2 — **Íleo paralítico**
sin obstáculo: la motilidad se inhibe

el intestino responde con

F18 — **Peristaltismo de lucha**
ondas visibles, dolor cólico y ruidos hiperactivos

2 · CAUSAS DEL ÍLEO MECÁNICO

Hernias (25 %)
sobre todo inguinales; el asa se atrapa y puede estrangularse

Tumores (16 %)
extrínsecos o intrínsecos; en personas de edad

F7 — **Invaginación** (4 %)
un tramo entra en otro; la más frecuente en menores de 2 años

F15 — **Vólvulo** (4 %)
torsión del sigmoide; en Puno, megacolon chagásico y dolicomegacolon de altura

F3 · F14 · F27 — **Bridas y adherencias** (35 %)
la causa más frecuente; cesáreas, peritonitis, apendicectomías; meses o años después

encabeza la

F6 · F24 — **Lista del docente**
bridas 35, hernias 25, tumores 16, vólvulo 4, invaginación 4; también estenosis, áscaris, fecaloma y cálculo biliar

atrapa el asa y causa

mete un tramo en otro y causa

angula el asa y causa

tuerce el asa y causa

cierra la luz y causa

en fase avanzada se suma un

sin reposición agrava el

si es en el delgado se llama

si es en el colon se llama

3 · DEL TAPÓN A LA PERFORACIÓN

F8 — **Acumulación antes del tapón**
gas (aire tragado y fermentación) y líquido (secreción y plasma que trasuda); sube la presión

si no se resuelve produce

eleva la presión y produce

Compresión vascular
primero las venas, luego las arterias: edema, tercer espacio y translocación bacteriana

puede ser

F10 — **Simple o estrangulada**
simple solo cierra la luz; estrangulada corta además el riego

con pérdida de líquido causa

si persiste lleva a

si es estrangulada produce

F13 — **Isquemia y necrosis**
asa oscura y fina que se rompe

F12 — **Déficit de volumen**
vómitos y secuestro de líquido: deshidratación, hipotensión y taquicardia

cuando el asa se agota produce la

produce el

es un caso fisiológico de

avisa con la

sin reposición lleva a

con infección da

si se perfora causa

F17 — **Alarma**
el cólico cesa a las 4 h con dolor continuo y más distensión: estrangulación

F22 — **Leucocitosis con desviación a la izquierda**
bandas, por isquemia e infección

Falla de varios órganos si la hipovolemia sigue sin reposición

indica urgencia y orienta la

si no se opera termina en

inhibe la motilidad y produce

Perforación y peritonitis con toxemia y choque

4 · ALTA Y BAJA: VOLUMEN Y ÁCIDO-BASE

Obstrucción alta (delgado)
vómitos precoces y abundantes; poca distensión

su silencio avanzado refleja un

por el vómito se pierde

el vómito precoz da

Pérdida de HCl y K+
por el vómito de jugo gástrico

deja la sangre en

F16 — **Alcalosis metabólica hipoclorémica**
con hipopotasemia

al inicio da

F21 — **Obstrucción baja** (colon)
vómitos tardíos y luego fecaloideos; mucha distensión

distendido, segrega y absorbe poco:

con flora abundante hay

sin comer produce

Secuestro de líquido
segrega más, absorbe menos y es más permeable: pérdida de Na+ y K+

Catabolismo
sin ingesta se queman proteínas y grasas: cetonas y lactato

Proliferación bacteriana
flora del colon y pared isquémica: bacteriemia y toxemia

produce la

pasa a la sangre y causa

pierde Na+ y K+ y contribuye a la

Acidosis metabólica
la marca de la obstrucción baja

Sepsis y choque séptico

5 · CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO

distiende y da

al no pasar nada da

Ruidos hidroaéreos
metálicos al inicio; en fase avanzada, silencio: no descarta obstrucción

se manifiesta con

F4 · F9 — **Dolor cólico**
episodios de 30 s a minutos, cada 3 a 10 min

Distensión
poca en la alta, mucha en la baja; abdomen globoso

F25 — **Vómitos**
primero biliosos, luego oscuros y fétidos (fecaloideos)

F20 — **Falta de gases y heces**
signo capital de la obstrucción completa

se estudia con

sin corregir agrava hasta la

con la distensión se confirma con

con deshidratación se pide

se confirma con la

F11 · F26 — **Rx de abdomen de pie**
asas dilatadas con niveles hidroaéreos en escalera; TAC; la gasometría no hace el diagnóstico

Laboratorio
hemoconcentración, leucocitosis, urea y creatinina, ionograma y gasometría

confirmada orienta la

guía la reposición de la

Conducta (literatura): sonda nasogástrica, ayuno, hidratación y electrolitos; cirugía si hay estrangulación o perforación

6 · ÍLEO PARALÍTICO

F19 — **Posquirúrgico fisiológico**
dura 48 a 72 h; luego salen gases y heces

F23 — **Causas**
peritonitis, cirugía, pancreatitis, trombosis mesentérica, hipopotasemia; cólico nefrítico, ACV, uremia, septicemia

Dolor continuo y fijo
silencio abdominal desde el inicio, sin peristaltismo

el tratamiento es

Tratamiento médico: se trata la causa

concepto · mecanismo · causa · ejemplo · complicación · diagnóstico · desenlace · síntoma · signo · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.° # de la lámina

Fuente: Clase 35 · Dr. Sotito — teoría del docente (= literatura)